

18 - 06- Le psoriasis - Pr. Amal

Après ce cours, l'étudiant en médecine doit être capable de diagnostiquer un psoriasis, le diagnostic de psoriasis et les cliniques. Il doit comprendre et expliquer aux malades la physiopathologie du psoriasis, identifier les formes compliquées du psoriasis, identifier les formes graves du psoriasis, connaître les principes du traitement du psoriasis. Le psoriasis est une dermatose hérédérmatosquameuse de cause inconnue, d'évolution chronique qui atteint environ 2% de la population.

Il y avait une étude qui a été faite dans les pays du Maghreb et on a estimé la prévalence du psoriasis au Maroc à 1,5%. Le psoriasis survient sur un terrain génétique particulier avec l'intervention de plusieurs facteurs environnementaux. Le psoriasis est caractérisé par un trouble de l'homéostasie épidermique.

Il y a un renouvellement accéléré des kératinocytes, qui est une hyperprolifération et trouble la différenciation kératinocytaire. Donc ici, la biopsie cutanée d'une peau psoriasique, ici la biopsie d'une peau normale pour voir un petit peu les anomalies et essayer de comprendre la physiopathologie du psoriasis. Tout d'abord, la biopsie n'est pas utile en matière de psoriasis.

Elle est rarement utilisée pour éliminer certains diagnostics différentiels où il y a une ressemblance clinique importante. Le cas, par exemple, du psoriasis en gouttes. Donc là, c'est juste pour vous montrer les anomalies qu'on a. On va commencer par la peau normale.

Dans la peau normale, il y a ce qu'on appelle la kératinisation épidermique. Ici, vous avez la couche cornée. Tout ça, c'est l'épiderme.

Vous avez la couche cornée. Vous avez les cellules granuleuses, vous avez les cellules épineuses et vous avez la membrane basale. C'est ces cellules, ces kératinocytes qui existent au niveau de la membrane basale qui vont former par la suite, qui vont arriver à la surface pour former les cornéocytes, c'est-à-dire les kératinocytes au niveau de la couche cornée.

Ces kératinocytes, en général, sont anucléés. Ce processus de renouvellement, de différenciation, c'est un processus normalement qui dure 21 jours. En cas de psoriasis, ce cycle est raccourci.

Il est de 3 à 7 jours. C'est pour cela que, si vous voyez la peau psoriasique, vous avez l'absence de la couche granuleuse à cause de ce renouvellement rapide. Vous avez une hyperkératose parakératosique, c'est-à-dire un épaissement de la couche cornée, mais avec des cornéocytes parfois qui gardent leur noyau, donc une couche cornée de mauvaise qualité.

Vous avez un allongement des papilles dermiques et vous avez un infiltrat inflammatoire important au niveau du derme, donc fait de l'infocyte. On peut trouver également à l'intérieur de l'épiderme des abcès à polynucléaires neutrophiles. Ce sont les anomalies qu'on voit au cours du

psoriasis.

Voilà pour récapituler les anomalies qu'on a. Donc, une couche cornée de mauvaise qualité, une hyperkératose parakératosique, l'absence de couche granuleuse, un épiderme épaissi en part d'acanthose, donc le renouvellement cellulaire accéléré. Et ce sont les lymphocytes, donc c'est l'activation des lymphocytes qui joue un rôle important dans le déclenchement de ce processus de renouvellement cellulaire accéléré. Donc la physiopathologie du psoriasis a connu plusieurs avancées.

Le psoriasis, au départ, on a une activation des cellules dendritiques. Il y a cette cellule dendritique plasmacytoïde qu'on trouve de façon très importante chez les malades psoriasiques au niveau de la peau, alors qu'elle est absente dans une peau normale. L'activation de ces cellules dendritiques, les secondaires, a un antigène.

On n'arrive pas jusqu'à maintenant à l'identifier. Probablement, c'est un auto-antigène. On considère le psoriasis comme une maladie auto-inflammatoire, mais également, il y a des antigènes liés à l'environnement.

Par exemple, le streptococque, puisqu'il y a des psoriasis déclenchés par l'infection streptococcique, après une angine, par exemple, chez les enfants. On va voir ça par la suite, le psoriasis en gouttes. Il y a le psoriasis qui peut être déclenché par l'infection VIH.

On a vu le psoriasis dans les manifestations de VIH. Il y a le stress également qui peut déclencher le psoriasis. Il y a certains médicaments.

Donc il y a des auto-antigènes, mais il y a également certains facteurs environnementaux qui peuvent donc initier ce processus de stimulation, d'activation des cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques, donc ils libèrent sur ce TNF α un interférent gamma, vont activer par la suite les lymphocytes. Donc les lymphocytes avec trois voies d'activation, T1, T22 et T17.

Et l'activation de ces lymphocytes, ils jouent un rôle très important dans le maintien de cette inflammation chronique, puisque le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique. Ces lymphocytes activés vont libérer l'interleukine 17A, qui joue un rôle important, l'interleukine 22. Et cette connaissance de cette physiopathologie a permis d'améliorer la prise en charge thérapeutique parce qu'il y a des médicaments qui ont été découverts.

Ils ont été commercialisés et qui ont une activité anti-interleukine 17A ou anti-interleukine 22. Également, donc, les anti-TNF α . D'accord? Tous ces toxines vont, bien sûr, maintenir cette inflammation chronique.

Ils donnent une vasodilatation, un influx important du polynucléotrophile. C'est pour cela qu'on trouve des abcès de polynucléotrophile au niveau de l'épiderme. Un influx de lymphocytes T, donc une activation kératine ocitaire, recrutement des monocytes et neutrophiles,

myovascularisation.

Donc, tout ça, c'est secondaire à ces cytokines libérés par les lymphocytes. On a vu les anomalies histologiques qu'on voit dans le psoriasis. On a vu les mécanismes lésionnaires.

Maintenant, on va voir les facteurs étiopathogéniques. Tout d'abord, il y a une prédisposition génétique. Cette prédisposition génétique, les arguments qui sont en faveur de cette prédisposition génétique, c'est l'existence des cas familiaux dans 30 % des cas.

Également, il y a un taux de concordance de 60 % dans les gemmos monozygotes. Et en matière de psoriasis, les gènes de prédisposition sont multiples et localisés sur différents chromosomes. Le HLA-CW8 est le gène de prédisposition majeur.

Sur ce terrain génétique, il y a des facteurs d'environnement qui peuvent initier un psoriasis ou aggraver un psoriasis déjà connu ou provoquer des poussées. Ces facteurs d'environnement, il y a le stress, le climat. En général, le froid aggrave le psoriasis.

L'infection streptococcique chez l'enfant et VIH chez l'adulte. Les traumatismes, le frottement, peuvent provoquer des lésions de psoriasis chez un sujet prédisposé génétiquement. C'est pour cela qu'on voit les lésions de psoriasis, surtout au niveau des régions du corps qui subissent des traumatismes, les genoux, les coudes.

Ces facteurs permettraient l'expression du psoriasis chez des sujets génétiquement prédisposés. Il y a aussi l'alcool et le tabac qui sont des facteurs de gravité et de résistance thérapeutiques. Les facteurs infectieux, on trouve les infections streptococci qui peuvent déclencher une nouvelle poussée ou aggraver un psoriasis déjà existant.

Ça donne chez les enfants surtout des poussées de psoriasis en goutte. Et également un VIH chez les sujets adultes. On trouve également certains médicaments qui peuvent aggraver un psoriasis déjà existant ou initier un psoriasis ou déclencher un psoriasis.

Vous avez les sels de lithium utilisés en psychiatrie, les bêtas bloqueurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, donc des antihypertenseurs, l'interféron alpha, les antipaludéens de synthèse. Et également les facteurs psychologiques, le stress, par exemple la notion de deuil, de séparation familiale, des problèmes professionnels peuvent déclencher la maladie ou aggraver le psoriasis déjà existant. Et bien sûr, le psoriasis, en tant que maladie inflammatoire chronique, peut altérer la qualité de vie des patients.

Donc il peut donner un retentissement psychologique important. Donc sur le plan psychologique, également social et relationnel de la maladie, il peut donc être responsable des dépressions et des anxiétés chez les patients. On va voir ça par la suite.

Donc sur le plan clinique, la lésion élémentaire, c'est une plaque érythémato-squameuse. Donc vous voyez, les squames sont blanchettes, qui sont épaisses. Et au-dessous des squames, vous

avez de l'erythème.

Donc c'est des lésions érythémato-squameuses. Il y a deux signes cliniques, signe de la tâche de bougie et signe de la rosée sanglante. Donc le signe de la tâche de bougie, c'est le fait de gratter ces squames à l'aide d'une curette ou d'un abaisse-langue.

Donc on détache d'abord de nombreux petits coupons blanchâtres, avant de retirer un dernier coupon plus large recouvrant du derme. Et à ce moment-là, le derme est mis à nu. Il y a l'apparition d'un saignement, ce qu'on appelle signe de la rosée sanglante.

Voici le signe de la rosée sanglante. Donc après avoir enlevé les squames, vous avez un saignement. Vous avez le derme à nu et vous avez un saignement.

Donc le nombre de lésions est variable. Il peut y avoir une ou deux lésions. Une lésion au niveau du coude ou au niveau du genou.

Et parfois, on a des dizaines de lésions. La même chose, les dimensions des lésions sont variables. Vous avez des lésions en points.

On parle du psoriasis punctata, donc c'est un terme latin, ou psoriasis sous forme de gouttes. On parle du psoriasis glutata, psoriasis numulaire, lésion à la taille d'une pièce de monnaie, ou des plaques. Donc on parle du psoriasis en plaques.

Voici un aspect du psoriasis en gouttes. Voici un patient qui présente des lésions de taille variable, donc des lésions en plaques. Vous avez des lésions en points, des lésions en gouttes, et des lésions sous forme numulaire.

Chez le même patient, il peut y avoir des lésions de taille variable. Pour la topographie des lésions, il y a une prédilection pour certaines zones, notamment les coudes et les genoux, les bords cubitaux des avant-bras, la région lombosacrée, au niveau de la région pré-tibiale, la teinte du couvert-chevelu, la région rétro-oculaire, la teinte de l'ombilique. Les squames, on a dit, ce sont des squames blanches épaisses.

Quand on les regarde, on a ce qu'on appelle le signe d'attache de bougie. Au-dessous des squames, vous avez une peau rouge, et cette rougeur, ça se voit en périphérie de la lésion, donc on parle de lésion érythémate, parce que c'est rouge, squameuse. Voici donc la topographie élective des lésions.

Vous avez la teinte du genou, la teinte du coude, donc des lésions érythémato-squameuses, avec des squames épaisses, la région pré-tibiale, vous voyez les lésions, les genoux, la région pré-tibiale. Donc le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire chronique. Il est voulu par poussée et rémission, et parfois le malade peut rester en rémission des années, donc c'est variable entre les malades.

Il y a certains malades qui font beaucoup de poussée, et certains malades font donc peu de poussée. C'est une maladie qui est photosensible, ça veut dire que c'est une maladie qui peut s'améliorer par l'exposition solaire, c'est parmi les rares maladies où on conseille aux patients de s'exposer au soleil. Mais il faut savoir que 5% des malades, des psoriasis, peuvent être aggravés par l'exposition solaire.

Mais généralement, le soleil, c'est parmi les méthodes thérapeutiques qu'on peut utiliser pour la prise en charge du psoriasis. Donc il y a plusieurs formes cliniques. Les formes cliniques, elles sont variables selon la taille et le nombre de lésions.

Donc on a vu, les lésions peuvent être de taille différente, sous forme de points, de gouttes, de pièces de monnaie, ou sous forme de plaques. Le nombre également des lésions est variable. Chez certains patients, on ne peut trouver qu'une ou deux lésions au niveau du coude ou au niveau du genou.

Chez certains malades, on trouve des centaines de lésions. Il y a des formes symptomatiques en fonction de la morphologie. Donc il y a des lésions qui sont circidées, qui prennent un aspect annulaire.

Il y a certaines formes cliniques avec des papules folliculaires, qui ressemblent à l'eczéma folliculaire. Il y a également des formes symptomatiques en fonction de l'intensité de l'hyperkeratose. Parfois, il y a une hyperkeratose très importante avec des lésions qui sont dures.

On parle du psoriasis postriacé ou des rochers psoriasiques, surtout au niveau du coude chevelu. Il y a également, dans les formes symptomatiques, le phénomène de Kovner. Le phénomène de Kovner, c'est l'apparition des lésions du psoriasis après un frottement, après un traumatisme.

Plus souvent, un frottement impurite peut déclencher des lésions du psoriasis sur les lésions qui ont subi le frottement. C'est pour cela qu'on demande aux patients de ne pas se frotter dans les bains morts. Voici le phénomène de Kovner.

Le malade se gratte. Il n'y avait rien au niveau de la peau. Sur ces lésions de grattage, il y a l'apparition secondaire des lésions de psoriasis.

C'est ça, le phénomène de Kovner. Il faut savoir que le psoriasis, classiquement, n'est pas une maladie plurigineuse. Mais, en pratique, on trouve le plurit à peu près chez les deux tiers des patients.

Il y a également des formes cliniques selon la topographie. On a dit que la topographie classique, c'est les coudes et les genoux. Mais il peut y avoir des localisations au niveau des plis.

Et on parle du psoriasis inversé. Donc, ça donne des lésions héritementeuses. Les squam, en

général, au niveau des plis, ce n'est pas la même chose qu'au niveau des autres régions.

Les squam peuvent être absents. Donc, on trouve surtout un irritant. Ça siège au niveau des plis.

Donc, ça peut siéger au niveau des plis interfessiers, des plis inguinaux, de la région génitale, sous la mère, l'ombilique, la creux poplite, le côté axélaire et les espaces interdigitaux plantaires. Mais en général, ça siège au niveau des grands plis. Voici les lésions du psoriasis inversé.

Vous voyez que l'irritant est important. Et il n'y a pas de squam, comme on voit dans les localisations classiques. Le diagnostic différentiel va se poser avec les dermatophyses.

Mais les dermatophyses, rappelez-vous, c'est des lésions... En général, on trouve des visicules ou des pustules au niveau de la bordure, au niveau de la périphérie des lésions, avec une tendance à la guérison centrale. Le diagnostic différentiel peut se poser également avec une candidose. Dans les candidoses, en général, on a des pustules et un enduit blanchâtre au niveau, au fond des plis.

L'irritasma, la couleur ici est différente. Ici, c'est rouge vif. Dans l'irritasma, c'est une couleur jaune chamois.

Le psoriasis du queer chevelu, la localisation au niveau du queer chevelu, on a dit que c'est une localisation fréquente. Il y a des lésions érythématosquameuses. Ça commence parfois sous forme de pellicules ou de dermites séboréiques.

On parle de psoriasis. Vous voyez les lésions érythématosquameuses, non alopeciennes. Ça ne donne pas une alopecie.

Comme diagnostic différentiel, surtout chez l'enfant, il y a des teignes, mais ça ne donne pas une alopecie contrairement aux teignes du queer chevelu. Là, ça ressemble à la dermite séboréique. Dans la dermite séboréique, vous avez des lésions érythématosquameuses avec une atteinte au niveau de la lisière du queer chevelu.

Si le malade présente des lésions de psoriasis dans d'autres sièges, au niveau du coude ou du genou, le diagnostic est facile. Parfois, vous avez des lésions isolées du queer chevelu et ça pose un problème de diagnostic différentiel avec la dermite séboréique. Parfois, on parle de sébopsoriasis.

On n'arrive pas à faire la différence entre ces deux dermatoses. L'atteinte du visage se voit surtout dans les formes graves. On a dit que ça peut donner des lésions.

Donc, ça ressemble aux lésions que l'on voit dans la dermite séboréique. Il y a aussi la localisation palmo-plantaire. Le palmo-plantaire peut être localisé.

On parle de keratodermie en îlot lorsqu'il est localisé. Parfois, ça touche toute la pomme des

mains ou la plante du pied. On parle de keratodermie diffuse.

Voici les lésions de psoriasis au niveau des mains. Ici, vous voyez un épaissement de la couche cornée. Donc, une keratodermie palmaire plantaire avec des fissures.

Une keratodermie plantaire fissuraire. Le diagnostic différentiel se pose surtout avec l'eczéma chronique. Il y a également l'atteinte sanguinale.

Donc, le psoriasis sanguinal. La même chose, il peut y avoir un psoriasis sanguinal isolé. Mais le plus souvent, le psoriasis sanguinal.

Donc, il est associé au psoriasis au niveau de la peau. Et également, il est associé avec le psoriarthropathique. Donc, le psoriasis sanguinal, on peut trouver des lésions, des dépressions que vous voyez ici.

Donc, des dépressions ponctuées. Il peut y avoir un aspect de l'onychie, c'est-à-dire un aspect blanchâtre de l'ongle. Il peut y avoir une onycholyse, c'est-à-dire un décollement de l'ongle par rapport au lit de l'ongle.

Il peut y avoir une hyperkeratose sanguinale, comme vous voyez ici. On parle de pachyonychie. Le principal diagnostic différentiel ici, ce sont les onychomycoses.

Voici les lésions. Donc, les ponctuations qu'on appelle les ponctuations en D à coudre. Voici un aspect de l'onychie, un aspect blanchâtre de l'ongle.

Voici une onycholyse avec une tache rouge qu'on appelle la tache d'huile qu'on voit dans le cadre du psoriasis. Il y a aussi la possibilité d'atteindre des muqueuses avec un aspect de l'ongle géographique et un aspect au niveau de la verge, un aspect de l'ongle géographique. Donc, 15% des cas de psoriasis commencent avant l'âge de 10 ans.

En général, les filles sont plus touchées que les garçons et on trouve des antécédents familiaux de psoriasis. La particularité symptomatique du psoriasis chez l'enfant, c'est la prédominance du forme clinique du psoriasis aiguë en goutte faisant suite à une infection streptococcique et le psoriasis numulaire. Vous voyez donc le cas chez cet enfant, le psoriasis numulaire, les lésions sont des lésions érythématosquameuses qui ont la taille d'une pièce de monnaie.

On peut voir également le psoriasis chez le nourrisson et les lésions prédominent au niveau du siège et on parle de psoriasis des ongles, en anglais, napkin psoriasis. Donc, ça peut donner des lésions du siège isolé mais parfois il y a atteinte au niveau du corps comme vous voyez chez ce nourrisson. Donc, le psoriasis peut se compliquer d'une surinfection par le staphylocoque surtout, on parle d'impétiginisation ou bien il peut y avoir une éczématisation des lésions, en général secondaire à l'application des produits traditionnels qui peuvent donner des lésions donc d'eczématisation avec une priorité importante en source de surinfection et à cause des priorités il peut y avoir des lésions de lignification c'est-à-dire que la peau en général devient épaissie

quadrillée.

Donc, les formes graves du psoriasis, il y a le psoriasis électrodermique, le psoriasis pustuleux et le psoriasis arthropathique. Donc, le psoriasis électrodermique ce que vous voyez sur cette image, c'est l'étendue, c'est l'érythème qui touche plus de 90% de la surface corporelle associée à ces squames que vous voyez. En général, le psoriasis électrodermique est provoqué par une corticothérapie, donc prise par voie orale ou par voie systémique des injections intramusculaires.

Le psoriasis électrodermique, c'est une urgence, il faut hospitaliser le malade parce que la surface de la peau est étendue et ça peut donner des complications hydroélectrolytiques. Vous voyez les lésions, donc c'est des lésions généralisées sur tout le corps, 90% de la surface corporelle. Vous voyez toujours des cas de psoriasis électrodermique.

Il y a le psoriasis pustuleux. Donc, le psoriasis pustuleux, en général, il peut survenir après prise médicamenteuse ou après une prise de la corticothérapie et c'est à l'arrêt de la corticothérapie que le malade développe ses pustules généralisées au niveau du corps ou bien chez la femme enceinte. Les pustules, ce sont des pustules amicrobiennes.

Si vous faites le prélèvement bactériologique ou le prélèvement mycologique, vous ne trouvez pas de germes. Donc, si on fait une biopsie, on a une pustule, ce qu'on appelle la pustule spongiforme de Cogorg-Lapierre, donc il y a une spongiose avec donc la localisation de ces pustules au niveau de la couche superficielle du corps mykieux. Dans le psoriasis pustuleux, il y a des formes localisées et des formes généralisées.

Donc, les formes localisées, on les trouve au niveau des extrémités. Donc, il y a le psoriasis pustuleux palmoplantaire qu'on appelle le psoriasis pustuleux palmoplantaire de Barber et il y a des formes qui sont localisées au niveau des doigts ou des orteils. On parle de psoriasis pustuleux acral ou acrodermatite de Harrop.

Donc, vous voyez dans le psoriasis pustuleux palmoplantaire de Barber, vous voyez ici les lésions, donc les pustules. En général, c'est des pustules qui évoluent par poussée, ce qui est un priorité important. Il peut y avoir atteinte au niveau de l'imminence des mains, avec parfois une extension en dehors des mains et vous avez une atteinte au niveau de la, donc ici, vous voyez ici, au niveau plantaire.

Et vous avez les formes généralisées. Donc, la forme généralisée, vous avez la forme la plus sévère, ce qu'on appelle le psoriasis pustuleux généralisé grave de Zambouche. Donc, c'est un début brutal avec altération de l'état général, des placards érythémateux parsemés de pustules en large nappe superficielle.

Parfois, on a un tableau, donc, associant une électrodermie avec des pustules. Et l'évolution, donc, ces lésions évoluent vers une desquamation avec d'effervescence thermique. Voici, donc, vous voyez les images, donc sur ces placards érythémateux que vous voyez ici au niveau de,

donc de la cuisse, au niveau de la jambe, parsemées de pustules.

Et c'est des pustules qui sont amicrobiennes. Si vous faites des prélèvements, donc, il n'y a pas de staphylococque, il n'y a pas de, donc, d'autres agents bactériens. Omicrosique.

Voici l'association, donc, l'érythrodermie avec des pustules. Donc, après le psoriasis érythrodermique et le psoriasis pustuleux, vous avez le psoriasis arthropathique. Donc, le psoriasis arthropathique, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique.

Il peut survenir chez un patient connipsoriasique ou bien parfois l'atteinte articulaire précède l'atteinte cutanée et c'est le cas dans 10%. Vous avez deux types d'atteintes. Vous avez l'atteinte périphérique, le rhumatisme psoriasique périphérique et vous avez le rhumatisme psoriasique axial.

Donc, le rhumatisme psoriasique périphérique, les signes fonctionnels, c'est les douleurs articulaires, les arthragies. Il peut y avoir une atteinte oligo ou monoarthrite ou polyarthrite. Donc, une seule articulation, deux à trois articulations ou plusieurs articulations.

Les articulations touchées sont les doigts, les orteils, les poignets, les genoux, les chevilles, coudes et épaules. Et vous avez le rhumatisme psoriasique axial avec atteinte du rachis, surtout dorsolombaire et de l'articulation sacro-hélie. Voici des exemples de psoriasis arthropathique avec atteinte périphérique.

Donc, des articulations interphalangiennes avec des déformations. Vous voyez les lésions du psoriasis au niveau des dos de l'âme. Voici les lésions érythémateuses courbées et vous voyez les déformations articulaires.

Voici également, chez ce patient, vous avez l'atteinte articulaire avec l'inflammation ici que vous voyez. Et en général, dans le psoriasis articulaire, vous avez une atteinte inguinale, le psoriasis inguinale, qui est le plus souvent associé au psoriasis arthropathique. Donc, à côté de l'atteinte cutanée, de l'atteinte articulaire, il peut y avoir l'association avec d'autres comorbidités et notamment le syndrome métabolique avec l'obésité, l'HTA et le risque accru d'athérosclérose et d'infarctus de myocarde.

Le psoriasis également altère la qualité de vie et peut provoquer une dépression parfois sévère et des troubles anxieux. Il y a aussi un problème de contact social avec une stigmatisation et il y a d'autres facteurs qui peuvent aggraver le psoriasis. Donc, des facteurs comme le tabac et l'alcool et il faut prendre en considération tous ces éléments dans la prise en charge du malade psoriasique.

Dans le cadre du psoriasis, il peut y avoir donc une atteinte systémique, une atteinte digestive avec une fréquence élevée des colites inflammatoires chroniques. Il peut y avoir une atteinte pulmonaire et hépatique. Donc, le syndrome métabolique, il faut le chercher systématiquement

chez un patient psoriasique.

Il y a un risque relativement plus élevé de cardiopathie, d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension, de diabète, de dyslipidémie et d'obésité. Également, il y a une fréquence plus élevée de dépression et d'anxiété à cause de l'altération de la qualité de vie par cette dermatose affichante et chronique. Le diagnostic différentiel dans la forme classique, donc la forme classique de psoriasis vulgaire.

Donc, on peut discuter du psoriasis rosé-giber, mais la sémiologie et la topographie sont différentes. On va illustrer un cas de psoriasis rosé-giber par une photo et les eczématides. La dermatite séboréique, en cas de localisation au niveau du cuir chevelu, au niveau du visage.

La syphilis secondaire, donc avec les syphilis de psoriasis forme. Rappelez-vous, la syphilis secondaire est la grande simulatrice. Elle peut simuler plusieurs pathologies, y compris le psoriasis.

Et le lichen blanc qui a comme lésion élémentaire des papules et ces papules peuvent avoir donc des squames et ça pose le problème de diagnostic différentiel avec le psoriasis. C'est dans ces cas où on est amené parfois à faire des biopsies. Sinon, le diagnostic de psoriasis, c'est un diagnostic clinique.

Donc, voici un cas de psoriasis rosé-giber. Donc, psoriasis rosé-giber, on a déjà vu donc un cas similaire lorsqu'on a parlé de la syphilis secondaire comme diagnostic différentiel ou de la primo-infection VIH. Donc, vous avez une lésion érythématosquameuse de grande taille qu'on appelle le médaillon et puis sept jours après, vous avez l'apparition d'autres lésions de même aspect d'érythématosquameuse de petite taille que vous voyez ici.

Donc, la sémiologie, elle est très évocatrice. Il n'y a pas de signes généraux. Donc, ces lésions sont dues à une infection virale.

C'est de l'herpès human virus type VII et ces lésions le grossissent spontanément pendant quatre à six semaines. Pour les autres formes, les psoriasis inhabituelles, donc le diagnostic différentiel, c'est en fonction de la forme. Donc, au niveau de la localisation, au niveau des plis, à ce moment-là, on discute les autres étiologies des intertrigaux, intertrigomycosique, dermatophytose, ou candidosique, ou erythrasma, ou l'eczéma.

Les lésions au niveau de la paume et des plantes du pied, donc non en eukaryotodermie palmoplantaire, on discute surtout l'eczéma chronique. Donc, en psoriasis érythrodermique, on discute les toxidermies médicamenteuses, les hématodermies, c'est-à-dire les lymphomes cutanés, ou l'eczéma. En cas d'atteinte articulaire, donc le rhumatisme psoriasique, on discute surtout l'arthropathie inflammatoire ou dégénérative, surtout l'arthropathie inflammatoire, périphérique à la polarité trichromatoïde, ou un spondyloarthropathie lorsqu'il y a une atteinte.

Pour le psoriasis pustuleux généralisé, le diagnostic différentiel principal est la pustulose exentématique aiguë généralisée. Donc, c'est une forme de toxidermie médicamenteuse. Pour le psoriasis pustuleux palmoplantaire, vous avez les eczémas surinfectés, les dermatophyses plantaires supurées, les pustules qu'on voit dans le cadre de la maladie de Fessinger-Leroy-Reiter.

Rappelez-vous, la maladie de Fessinger-Leroy-Reiter, c'est une complication de l'urétrite non-gonococcique, l'urétrite aclamidia, qui rase le groupe, une atteinte, une conjonctivite bilatérale, qui revient, une valanite, une keratodermie palmoplantaire avec des pustules. On arrive au traitement et la prise en charge thérapeutique du psoriasis. Le but du traitement, c'est de réduire les lésions et de les rendre tolérables pour le patient.

Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement qui guérit le psoriasis de façon définitive. Donc, on a plusieurs moyens. On a des moyens, donc du thérapeutique local et du thérapeutique systémique.

Pour le thérapeutique local, on a la corticothérapie locale. Donc, on préfère la forme galénique pommade pour les lésions sèches, les crèmes pour les plis, les lotions pour le cuir chevelu. Également, il y a des shampoings qui contiennent des corticoïdes pour le traitement du psoriasis du cuir chevelu.

En dehors des lésions du visage, on utilise dans le psoriasis au moins un dermocorticoïde de classe 2. Une seule application par jour est suffisante. On peut utiliser des corticoïdes sous forme occlusive, surtout au niveau de la pomme ou au niveau de la planche du pied pour augmenter la pénétration et optimiser l'efficacité du traitement. Il peut y avoir une association possible avec les autres traitements du psoriasis, par exemple l'association avec la photothérapie ou l'association avec le traitement systémique.

Pour la corticothérapie locale, donc, il faut faire attention puisque c'est une dermatose chronique. Parfois, les lésions sont étendues, donc il y a le risque des effets secondaires. Les effets secondaires peuvent être des effets secondaires locaux, à type d'atrophie dermoépidermique, des vergetures, une hypertrichose, des surinfections, des troubles pigmentaires, soit des macules achromiques ou des macules hyperpigmentés.

On peut avoir des granulomes gludéales, surtout au niveau du siège, chez les enfants ou chez les nourrissons. Il peut y avoir des lésions de dermis péri-orales, donc des pustules péri-orales et également une rosacée du visage. Il peut y avoir des effets systémiques lorsqu'on applique les corticoïdes de façon chronique sur une grande surface avec une décompensation de diabète, un syndrome cushynoïde, un ralentissement de la croissance chez l'enfant, de l'ostéoporose et même l'insuffisance urinale aiguë après l'arrêt du traitement.

Toujours dans le cadre du traitement local, on a également les dérivés de vitamines T. La

vitamine T intervient dans le métabolisme phosphocalcique qui peut induire une hypercalcémie. Dans le psoriasis, il agit par inhibition de la prolifération et de la différenciation kératinocytaire. Elle a un rôle également d'immunomodulateur.

Plusieurs dérivés sont utilisés dans le traitement du psoriasis. Au Maroc, c'est seulement le calcipotriol qui est commercialisé. Il est utilisé à raison de deux applications par jour.

L'association est possible avec les dermocorticoïdes, avec les autres traitements de psoriasis tels la photothérapie et les traitements systémiques. Il ne faut pas dépasser 100 g de topique par semaine à cause du risque d'hypercalcémie. Son activité est globalement comparable aux dermocorticoïdes, mais il a une activité plus lente.

Son effet majeur, c'est l'absence d'atrophie, contrairement aux dermocorticoïdes. L'effet secondaire majeur est l'irritation cutanée, surtout sur le visage et sur les plis. Récemment, on a développé un produit qui associait les deux, la vitamine D et la corticothérapie locale.

Il associait le calcipotriol et le dipropionate de métaméthasone commercialisé sous le nom de Devovet. Ce produit est appliqué une fois par jour sur les lésions. A durée de traitement recommandée et de 4 semaines pour le traitement d'attaque, il est plus efficace que le calcipotriol seul ou le dipropionate de métaméthasone seul ou bien si on associe ces deux produits séparément.

La dose maximum journalier ne doit pas dépasser 15 grammes et la dose maximum par semaine ne doit pas dépasser 100 grammes. Donc il y a toujours le risque d'hypercalcémie parce qu'il contient de la vitamine D. Ce produit est utilisé dans les psoriasis qui atteignent moins de 30% de la surface corporelle. Les autres traitements topiques, on a les produits kératomystiques et les produits émollients.

Ce sont des produits qui luttent contre l'hyperkeratose qui permet de diminuer l'hyperkeratose. On a l'acide salicylique avec des concentrations différentes de 2 à 10%. Cette concentration est utilisée en fonction de l'âge du malade, il faut faire attention parce que l'acide salicylique est toxique par exemple pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Lorsqu'on a une lésion localisée par exemple au niveau de la plante du pied, à ce moment-là on fait une concentration de 10%. Vous avez des produits qui contiennent de l'urée donc à une concentration supérieure à 10% donc également il a un effet kératomystique. On peut utiliser également des bains d'eau claire ou salé ou de l'eau additionnée, d'huile de cadre.

Ce sont des produits qui sont des produits émollients qui servent à hydrater la peau. Dans les traitements topiques, on a Tazarotène, c'est un dérivé de la vitamine A mais il n'est pas commercialisé au Maroc. Après les traitements topiques, on a également les traitements physiques à base de photothérapie.

On peut utiliser les UVB, Aspect E3TL01, on parle de photothérapie UVB, ou on peut utiliser la puvathérapie, c'est-à-dire les UVA précédées par la prise d'un médicament comprimé d'un psoralen photosensibilisant, donc le nom commercial c'est Meladinin, ou Psoraderm. Donc en général, le patient nécessite 20 séances en moyenne à raison de trois séances par semaine ou parfois deux séances par semaine. L'idée, c'est trois séances par semaine.

Voilà donc une patiente dans le service de traitement par les UVB, donc c'est une cabine avec des lampes qui émettent soit des ultraviolets A ou les ultraviolets B en fonction du choix du traitement. Voici la patiente sous UVB, les résultats après une séance, donc on voit qu'il y a une amélioration. Après le traitement topique, le traitement physique, on passe au traitement généraux.

On a plusieurs produits, on ne va pas les détailler. Vous avez des ritinoïdes par voie générale dérivés de synthèse de la vitamine A. On a l'acétrétine au soriatane. Vous avez le méthotrexate, la cyclosporine.

Récemment, on a développé une arme thérapeutique qui est plus efficace, mais qui est plus chère, donc la biothérapie. Dans le cadre de la biothérapie, il y en a plusieurs produits. Ceux qui sont en rouge, ce sont les produits commercialisés au Maroc.

Vous avez l'éthanercepte, l'adalumimab, l'infliximab, le cycunimab, le cyquicunimab. Voici les résultats de certains patients sous ce traitement. Vous voyez que ça peut donner presque un branchement complet.

Les indications thérapeutiques dépendent de la gravité du psoriasis, donc un psoriasis électrodermique, un psoriasis arthropathique, un psoriasis pustuleux ne se traitent pas de la même manière qu'un psoriasis localisé. Du retentissement sur la qualité de vie des patients, des contre-indications éventuelles. Certains produits, on ne peut pas les utiliser parce qu'ils ont des contre-indications.

Par exemple, la cyclosporine chez un patient qui a une insuffisance rénale ou une HTA. La cétrétine, par exemple, chez un patient qui a une hypertriglicémie. Donc, il faut prendre en considération ces contre-indications dans le choix thérapeutique.

Et également, les antécédents du patient, surtout pour la biothérapie, par exemple, si vous avez des antécédents du cancer ou d'infection par l'hépatite. Donc, le traitement systémique est indiqué lorsque vous avez un psoriasis avec une surface corporelle atteinte supérieure à 10% ou le score de PASI supérieur à 10 ou une altération de la qualité de vie mesurée par une échelle qui s'appelle DLQI supérieur à 10. Ou bien, lorsque vous avez un retentissement physique psychologique ou social jugé significatif ou psoriasis localisé mais non contrôlé par un traitement topique bien conduit et responsable d'un handicap fonctionnel psychologique ou social jugé significatif.

Par exemple, une localisation kératodermie, palmoplantère. Donc, ça peut justifier un traitement systémique. Donc là, pour le score de PASI, c'est un score qu'il faut calculer.

Il y a de l'érythème, l'induration et la desquamation avec des scores en fonction de l'atteinte et en fonction de la topographie. Et puis, vous avez un score établi en fonction de la surface atteinte. Et après, il y a des calculs à faire pour définir ce score de PASI.

Et là, il y a le DLQU. Donc, c'est l'échelle qu'on utilise pour mesurer l'altération de la qualité de vie. Elle existe en dialecte marocain.

Donc, globalement, pour les formes habituelles, les formes localisées, on utilise un traitement topique. Pour les formes graves, on utilise un traitement systémique. On va commencer par la photothérapie et les rétinoïdes au méthotrexate ou au cyclosporine.

Pour le psoriasis, c'est la cétérine qu'on choisit en premier lieu. Pour une kératodermie palmoplantère invalidante, c'est la cétérine. Pour le rhumatisme psoriasique, c'est surtout le méthotrexate en premier lieu.

Voilà pour récapituler le schéma thérapeutique proposé pour le traitement du psoriasis. C'est un schéma qui a été proposé par un groupe marocain de la Société marocaine de dermatologie. L'indication du traitement en fonction de la surface corporelle, du score de PASI et de DLQU.

L'échelle de mesure de la qualité de vie. Si vous avez un score, si vous avez une surface corporelle atteinte supérieure à 10, PASI supérieur à 10, DLQU supérieur à 10, il faut donner un traitement systémique. C'est considéré comme un psoriasis modéré, sévère.

Le traitement systémique, c'est à base de photothérapie ou privathérapie. Le traitement systémique, donc rétinoïdes, cyclosporine ou méthotrexate. Et si échec de deux médicaments parmi ces traitements systémiques, on passe à la biothérapie.

Pour les formes légères, chez l'enfant ou chez l'adulte, donc on commence par un traitement topique à base de corticostéroïdes et dérivé de la vitamine D. Chez l'enfant, on peut utiliser également un produit qui n'est pas commercialisé au Maroc, surtout pour l'attention au niveau du visage, le tacrolimus. Donc, chez l'adulte, la même chose, corticostéroïdes, analogue de la vitamine D ou l'association des deux. Donc, rétinoïdes topiques n'est pas commercialisé au Maroc, tacrolimus n'est pas commercialisé au Maroc.

On peut s'aider dans tous les cas par les chélateurs. Pour décapier, lorsqu'on est devant des lésions qui sont épaisses, des hémolions. Et bien sûr, la prise en charge et la prévention des comorbidités, donc le syndrome métabolique et l'éducation thérapeutique du patient.

Donc, en guise de conclusion, le psoriasis est une dermatose chronique invalidante survenant sur un terrain génétiquement prédisposé. Plusieurs avancées dans la connaissance des mécanismes physiopathologiques donnent un espoir thérapeutique au patient. C'est une

maladie qui altère la qualité de vie et nécessite une prise en charge psychologique.